INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

Tipo do Documento	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**	Página 1/9	
Título do Documento	**PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRURGICO**	Emissão: 31/05/2026 Versão: 4	Próxima revisão: 31/05/2027

1. CONCEITO: É a infecção que ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico ou até 90 dias, a depender do tipo de procedimento, envolve qualquer órgão ou cavidade mais profunda do que fáscia e músculo que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia .

1.1 Responsável pela execução

SCIRAS e equipe assistencial

1.2 Indicações

Todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos cirurgicos eletivos, de urgencia e emergencia, nas unidades de centro cirurgico e ambulatorial.

1.3 Finalidades

- Padronizar a implementação de medidas para a prevenção de infecções de sitio cirúrgico e orientar as equipes assistenciais quanto a manutenção dessas medidas, com o objetivo de reduzir essas infecções e promover maior segurança aos pacientes.

2. MATERIAIS

- Checklist de cirurgia segura
- Antisséptico degermante (clorexidina 4% aquosa) para banho pré-operatório;
- Tricotomizador;
- Antomicrobiano profilático;
- Produto à base áalcool (PBA); ou Produtos á base de polivinilpirrolidona-iodo (PVPI); ou clorexidina (CHG) a 2% ou 4% para antissepsia cirúrgica de mãos e antebraços;
- EPIs;
- Roupa privativa;
- Campo estéril;
- Instrumentais cirúrgicos estéreis;
- Solução alcóolica a base de clorexidina a 2% ou PVI a 10% para antissepsia da incisão cirúrgica;
- Glicosímetro;
- Termômetro.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

PRÉ-OPERATÓRIO

1. Recomendações para o pré-operatório:

1.1 Praparo do paciente antes da internação:

- Identificar e tratar previamente quaisquer infecções em locais distintos do sítio cirúrgico antes da realização de cirurgias eletivas. Quando necessário, adiar o procedimento até a completa resolução da infecção.
-
- Realizar triagem para colonização por Staphylococcus aureus em pacientes submetidos a procedimentos de alto risco (como cirurgias com implantes, ortopédicas ou cardíacas) e, se indicado, instituir protocolo de descolonização:
-
- − Banho diário com clorexidina 4% por cinco dias consecutivos, evitando contato com olhos e ouvidos;
- − Aplicação de mupirocina intranasal (formulação específica para uso nasal) na face anterior de ambas as narinas, duas vezes ao dia (manhã e noite), durante cinco dias;.
-
- Para pacientes que não permanecerão internados na véspera, orientar a realização de banho corporal completo com água e sabão neutro na manhã da cirurgia, conforme protocolo institucional.

1.2 Preparo do paciente – após a internação

Banho com antisséptico:

- Avaliar a indicação conforme o tipo de cirurgia, especialmente em procedimentos de grande porte, como ortopédicos com prótese ou implante, neurocirurgias e cirurgias cardíacas;
- Quando indicado, realizar o banho com antisséptico degermante (clorexidina 4% aquosa) aproximadamente duas horas antes da cirurgia, assegurando a proteção das mucosas oculares, orais e auditivas;
- Após o banho, minimizar o risco de recontaminação garantindo a troca do pijama/camisola, da roupa de cama e verificando se a cobertura da maca de transporte também foi substituída, conforme protocolo institucional;

Remoção de pelos corporais:

- Realizar a tricotomia somente quando estritamente necessária, ou seja, quando os pelos interferirem diretamente na incisão ou na adesão de curativos;
- Quando indicada, realizar a remoção fora da sala cirúrgica, imediatamente antes do procedimento, utilizando dispositivo elétrico (tricotomizador) com lâmina descartável, conforme POP da instituição;

Remoção de itens que comprometam a segurança e a assepsia:

- Garantir a retirada de todos os adornos pessoais (anéis, brincos, pulseiras, colares, relógios), piercings, cílios postiços, unhas postiças, esmalte (principalmente escuro ou descascado), alongamentos e cabelos sintéticos. Essa medida visa prevenir queimaduras, interferências em equipamentos como o bisturi elétrico e reduzir o risco de contaminação do campo operatório.

1.3 Profilaxia antimicrobiana

- Administrar antimicrobianos profiláticos apenas quando houver indicação formal, selecionando o medicamento com base na sua eficácia contra os principais patógenos associados às ISC para o tipo de cirurgia a ser realizada;
- Seguir o POP institucional em caso de situações específicas, como colonização por microrganismos multirresistentes, a exemplo do Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA);
- Garantir a administração do antimicrobiano profilático dentro do intervalo adequado antes da incisão cirúrgica: até 60 minutos para a maioria dos medicamentos, exceto vancomicina e fluoroquinolonas, cuja infusão deve ser iniciada entre 60 a 120 minutos antes da incisão;
- Descontinuar o antimicrobiano após o fechamento incisional, na sala cirúrgica.

1.3 Antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços

- Remover todos os adornos (anéis, relógios, pulseiras) antes do procedimento;
- Manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte;
- Não utilizar unhas artificiais;
- Realizar a antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços antes de todo procedimento cirúrgico, com o objetivo de reduzir a carga microbiana da pele e prevenir infecções no sítio cirúrgico, utilizando uma das duas técnicas recomendadas:
- -Degermação com antisséptico degermante, utilizando produtos à base de polivinilpirrolidona-iodo (PVPI) a 10% ou clorexidina (CHG) a 2% ou 4%, associados a detergente. Essa técnica exige o uso de água corrente e tempo adequado de fricção;
- -Fricção com produto à base de álcool (PBA) específico para uso cirúrgico, com ou sem associação a antissépticos adicionais (como a CHG).
- Evitar a combinação sequencial de antisséptico degermante (PVPI ou CHG) com produto à base de álcool, uma vez que isso pode interferir negativamente na ação dos compostos;
- Não utilizar escovas com cerdas rígidas, pois podem causar lesões na pele.
-

1.4 Preparação do campo cirúrgico e controle de instrumentais estéreis

- Realizar a montagem da mesa cirúrgica imediatamente antes do início do procedimento, a fim de preservar a esterilidade dos instrumentais;
- − Utilizar apenas instrumentais cirúrgicos esterilizados, adequados ao procedimento;
- − Conferir a validade do processo de esterilização e a integridade das embalagens antes da abertura das embalagens;
- − Registrar no prontuário do paciente os indicadores químicos e integradores utilizados, garantindo a rastreabilidade dos instrumentais estéreis utilizados durante o procedimento cirúrgico.

1.5 Paramentação

- Antes de acessar a área restrita e iniciar a paramentação, vestir a roupa privativa fornecida pelo centro cirúrgico, bem como a touca (não utilizar tais vestimentas fora do ambiente cirúrgico);
- Realizar a paramentação conforme POP institucional;
- Utilizar gorro cobrindo todo o cabelo;
- Utilizar máscara que cubra totalmente boca, nariz e pelos da face, ao entrar na sala, desde a abertura dos materiais estéreis permanecer corretamente posicionada durante todo o procedimento;
- Utilizar óculos para proteção de mucosa ocular;
- Calçar sapatos fechados e limpos;
- Todos os profissionais que atuam na sala cirúrgica devem estar devidamente paramentados conforme sua função, seguindo as normas institucionais. A equipe de campo estéril deve utilizar paramentação completa: touca, máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial, avental estéril e luvas estéreis. Os demais membros da equipe devem utilizar, no mínimo, touca, máscara e vestimenta privativa limpa;
- Utilizar aventais impermeáveis de manga longa;
- Trocar vestimentas que se apresentarem visivelmente sujas, contaminadas por sangue ou por material potencialmente contaminante;
- Realizar troca de luvas antes do implante de próteses ou enxertos, antes do fechamento da pele e subcutâneo em cirurgias infectadas e antes do segundo tempo em cirurgias urológicas e artroscópicas.

1.6 Preparo da pele

- Realizar a degermação da área próxima à incisão cirúrgica antes da aplicação da solução antisséptica;
- Aplicar solução alcoólica à base de clorexidina a 2,0% na área da incisão, abrangendo uma extensão ampla o suficiente para contemplar possíveis ampliações da abordagem cirúrgica, incisões adicionais ou locais de inserção de drenos;
- Em casos de contraindicação ao uso de clorexidina (como reações alérgicas, cirurgias otológicas ou oftalmológicas), pode-se utilizar um iodóforo em base alcoólica, como o PVPI a 10%;
- Cobrir a área operatória com campos estéreis amplos, de modo a isolar completamente a área ao redor da incisão e manter as condições de assepsia durante todo o procedimento;

INTRAOPERATÓRIO

1. **Profilaxia antimicrobiana – reaplicação intraoperatória (repique).**

- Em procedimentos com longa duração, considerar a repetição da dose intraoperatória após um intervalo igual a duas vezes o tempo de meiavida do antimicrobiano, a contar do início da infusão da primeira dose, conforme protocolo institucional e características do fármaco.

2. **Controle metabólico**

- **Controle glicêmico**:
  -Manter a glicemia entre 110 e 150mg/dL durante o intraoperatório em pacientes com ou sem diabetes;
- **Manutenção da normotermia**:
  - Monitorar e registrar a temperatura corporal central durante todo o procedimento;
  -Manter a temperatura acima de 35,5°C, adotando medidas de aquecimento ativo quando necessário, para prevenir complicações relacionadas à hipotermia.

3. **Incisão e remoção de drenos**

- Realizar a incisão de drenos, preferencialmente em uma incisão diferente da cirúrgica;
- Utilizar, preferencialmente, sistema fechado de drenagem;
- Remover o mais breve possível.

PÓS-OPERATÓRIO

1. **Suspensão da profilaxia antimicrobiana**

- Suspender a antibioticoprofilaxia considerando que:
  - O tempo de antimicrobiano profilático não deve exceder 24 horas após o procedimento;
  -Não há indicação da manutenção da profilaxia antimicrobiana até retirada de drenos ou cateteres.

2. **Controle metabólico: controle glicêmico**

- Monitorar e manter a glicemia entre 110 mg/dL e 150 mg/dL, para pacientes adultos, até 24-48 horas no pós-operatório.

3. **Cuidados com o curativo**

- Realizar higiene das mãos antes e após a manipulação da ferida cirúrgica e dos drenos;
- Adotar técnica asséptica rigorosa durante todo o processo de curativo;
- Considerar as características da ferida, a fase do processo de cicatrização e as condições clínicas individuais do paciente para a escolha do tipo de curativo;
- Manter curativo estéril por 24 a 48 horas em feridas com cicatrização por primeira intenção, salvo em situações de saturação (ex.: curativo úmido, sujo, solto) ou por indicação clínica.

PARÂMETROS ESTRUTURAIS E AMBIENTAIS DA SALA CIRÚRGICA

- Manter as portas da sala cirúrgica fechadas durante todo o procedimento, evitando aberturas frequentes e circulação desnecessária;

- Assegurar o funcionamento contínuo do sistema de climatização, mantendo o controle de temperatura, umidade, fluxo de ar e pressão diferencial exigidos para salas cirúrgicas;
- Controlar a temperatura da sala cirúrgica entre 20 e 24°C e a umidade relativa entre 40 e 60%;
- Realizar o monitoramento contínuo da temperatura e umidade da sala cirúrgica;
- Manter o sistema de ventilação com filtragem adequada, preferencialmente com filtros HEPA;
- Observar o direcionamento adequado do fluxo de ar, com insuflação pela parte superior e retorno preferencialmente por grelhas posicionadas próximas ao piso;
- Realizar manutenção preventiva e corretiva periódica dos sistemas de climatização e ventilação;
- Manter pisos, paredes e tetos com materiais lisos, laváveis, impermeáveis e sem frestas;
- Restringir a entrada de materiais e objetos não essenciais, como bolsas, alimentos ou dispositivos pessoais;
- Controlar o número de pessoas presentes na sala cirúrgica, proporcionalmente ao seu tamanho e à complexidade do procedimento;
- Garantir que não haja interferência na área estéril do campo operatório nem em outras zonas críticas de assepsia;

LIMPEZA DO AMBIENTE

- Realizar limpeza concorrente entre os procedimentos cirúrgicos, com ênfase nas superfícies de maior contato e nos equipamentos utilizados, como mesa cirúrgica, mesas auxiliares, focos, monitores e bombas de infusão;
- Executar a limpeza terminal ao final das atividades do dia, garantindo a higienização completa de superfícies, equipamentos fixos, paredes, pisos e mobiliário da sala cirúrgica;
- Considerar a realização de limpeza terminal antes do próximo uso da sala nos casos em que houver grande quantidade de sujidade visível ou presença significativa de matéria orgânica;
- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies e equipamentos da sala cirúrgica exclusivamente com produtos saneantes regularizados na Anvisa, devidamente indicados para uso hospitalar em áreas críticas;
- Higienizar equipamentos móveis e reutilizáveis que serão retirados da sala cirúrgica previamente à movimentação, conforme protocolo institucional, para evitar contaminação cruzada entre setores;

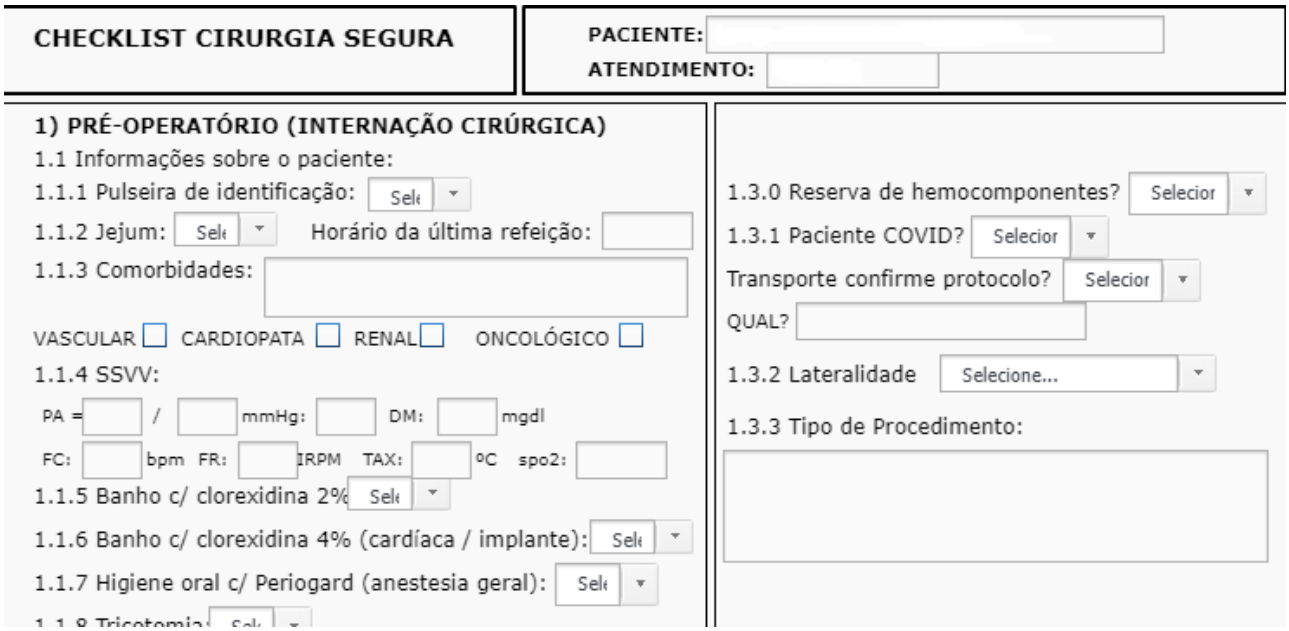
ENGAJAMENTO DE PACIENTES E FAMILIARES NA PREVENÇÃO DA ISC

- Engajar pacientes e familiares como parceiros ativos na prevenção da ISC, esclarecendo a importância do seu papel durante todas as etapas do cuidado – pré, intra e pós-operatória;
- Promover o entendimento sobre o procedimento cirúrgico, os riscos relacionados à infecção e os cuidados essenciais, por meio de orientações claras e acessíveis;
- Envolver o paciente nos cuidados pré-operatórios, orientando-o a cumprir rigorosamente o jejum prescrito, suspender medicamentos quando indicado e realizar o banho pré-operatório conforme instruções da equipe de saúde;
- Esclarecer que a remoção de pelos corporais não deve ser realizada em casa e que, quando a tricotomia for necessária, deverá ser feita exclusivamente na unidade de saúde, utilizando máquina elétrica (clipper), nunca com lâmina, e apenas se os pelos interferirem no procedimento cirúrgico;
- Reforçar que, no dia da cirurgia, o paciente não deve usar maquiagem, cílios postiços, esmaltes (especialmente escuros ou descascando), unhas artificiais, cremes ou loções corporais, pois esses produtos comprometem a segurança do procedimento;
- Estimular o paciente a seguir corretamente a técnica do banho pré-operatório, utilizando os produtos indicados pela equipe, com atenção ao tempo e à forma de aplicação;
- Envolver os pacientes e seus familiares na vigilância de sinais e sintomas de infecção no pós operatório, como vermelhidão, dor, secreção ou febre, explicando quando e como procurar atendimento;
- Incentivar a adesão ao acompanhamento após a alta, especialmente em casos com indicação de vigilância ativa, explicando sua importância e os meios utilizados (retorno ambulatorial, contato telefônico, monitoramento estruturado);
- Promover um ambiente de escuta e respeito, estimulando que pacientes e familiares façam perguntas e participem das decisões relacionadas ao cuidado;

- Disponibilizar materiais educativos adaptados ao perfil sociocultural dos pacientes, em formatos diversos (impresso, audiovisual, verbal), como forma de fortalecer a coprodução do cuidado seguro.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

5.1 Checklist de ciurgia segura



CHECKLIST CIRURGIA SEGURA

PACIENTE:
ATENDIMENTO:

1) PRÉ-OPERATÓRIO (INTERNAÇÃO CIRÚRGICA)

1.1 Informações sobre o paciente:

1.1.1 Pulseira de identificação: Sel

1.1.2 Jejum: Sel Horário da última refeição:

1.1.3 Comorbidades:

VASCULAR ☐ CARDIOPATA ☐ RENAL ☐ ONCOLÓGICO ☐

1.1.4 SSVV:

PA = / mmHg: DM: mgdl

FC: bpm FR: IRPM TAX: ºC spo2:

1.1.5 Banho c/ clorexidina 2% Sel

1.1.6 Banho c/ clorexidina 4% (cardíaca / implante): Sel

1.1.7 Higiene oral c/ Periogard (anestesia geral): Sel

1.1.8 Tricotomia: Sel

1.3.0 Reserva de hemocomponentes? Selecior

1.3.1 Paciente COVID? Selecior

Transporte confirme protocolo? Selecior

QUAL?

1.3.2 Lateralidade Selecione...

1.3.3 Tipo de Procedimento:

6. REFERÊNCIAS

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+4+-+Medidas+de+Preven%C3%A7%C3%A3o+de+Infec%C3%A7%C3%A3o+Relacionada+%C3%A0+Assis t%C3%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/a3f23dfb-2c54-4e64-881c-fccf9220c373

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+2+-+Crit%C3%A9rios+Diagn%C3%B3sticos+de+Infec%C3%A7%C3%A3o+Relacionada+%C3%A0+Assi st %C3%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/7485b45a-074f-4b34-8868-61f1e5724501

CALEGARI, Isadora Braga et al. Métodos para vigilância de infecção do sítio cirúrgico pós-alta: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, p. eAPE019631, 2023. Disponivel em: https://www.scielo.br/j/ape/a/4NXK6DGLRTWFyymCnfT4pqP/.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 03/2025 Critérios Diagnósticos das infecções relacionadas à assistência à saúde de notificação nacional obrigatória – ano: 2025.** Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-gvims-ggtes-dire3-anvisa-no-03-2025/view.44

7. HISTORICO DE ELABORAÇAO/REVISAO		
VERSÃO	**DATA**	**DESCRIÇAO DA AÇAO/ALTERAÇAO**
01	01/08/2023	Atualização e padronização
02	01/08/2024	Revisão
03	31/05/2025	Revisão
04	31/05/2026	Revisão

Versão 1 - Elaboração Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra	Data: 01/07/2023
Versão 4 - Revisão Ana Carolina Gomes de farias Julia Chaves Rodrigues **Validação** Matheus Soares **Registro, análise e revisão final** Giulianna Carla Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra **Aprovação** Matheus Soares Sonia Delgado	Data: 31/05/2026